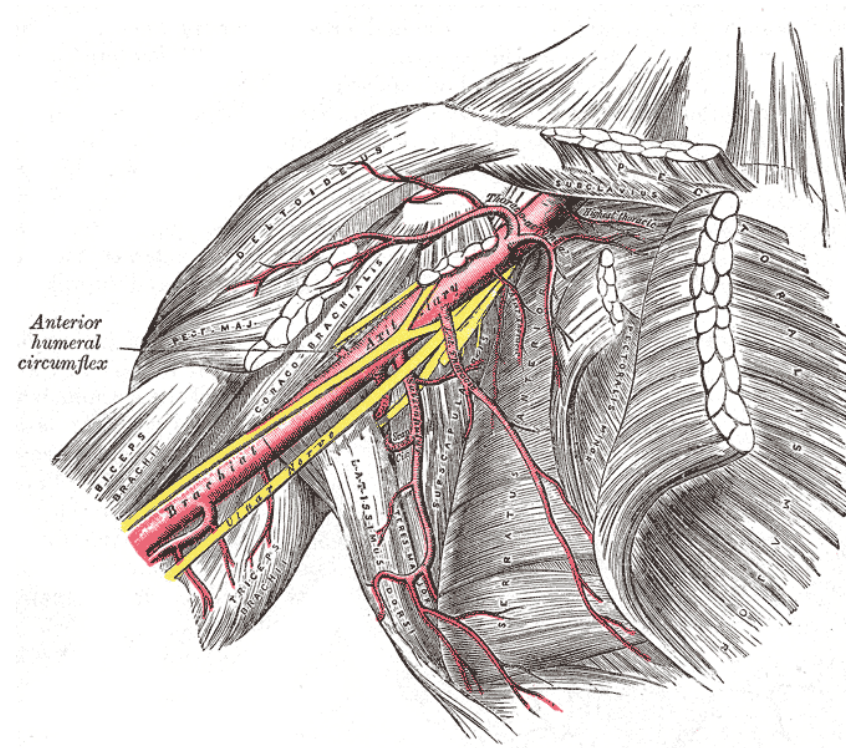


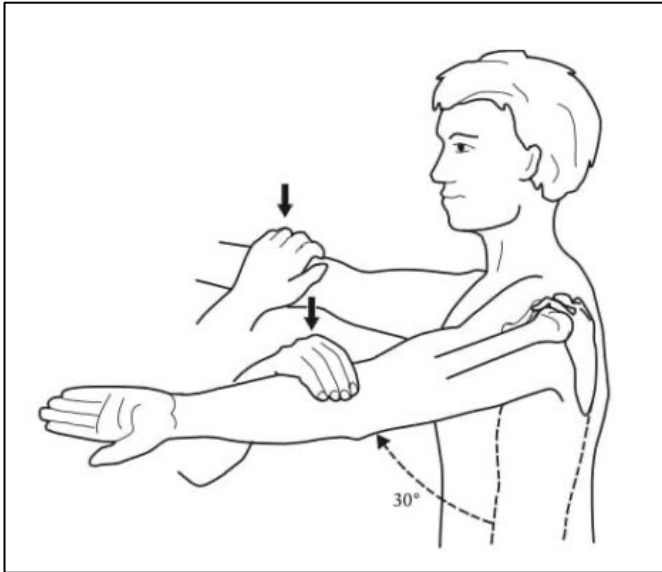
Épaule : Rappel des tests spécifiques et pathologies courantes



Épaule : Tests spécifiques

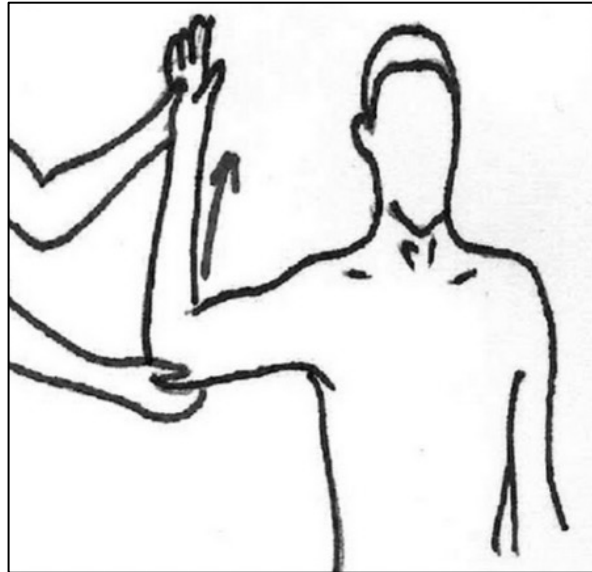
Coiffe des rotateurs : Test de Jobe

- Pour tester le muscle **sus-épineux** (nerf supra-scapulaire) tout en désengageant le deltoïde dans l'abduction de l'épaule



Coiffe des rotateurs : Test de Patte

- Pour tester les muscles **sous-épineux** (supra-scapulaire) et **petit-rond** (nerf axillaire), les rotateurs externes de l'épaule
- Patte 1 : Effectué les coudes collés au corps → muscle sous-épineux
- Patte 2 : Effectué lors d'une abduction à 90° → muscle petit-rond



Coiffe des rotateurs : Signe du clairon

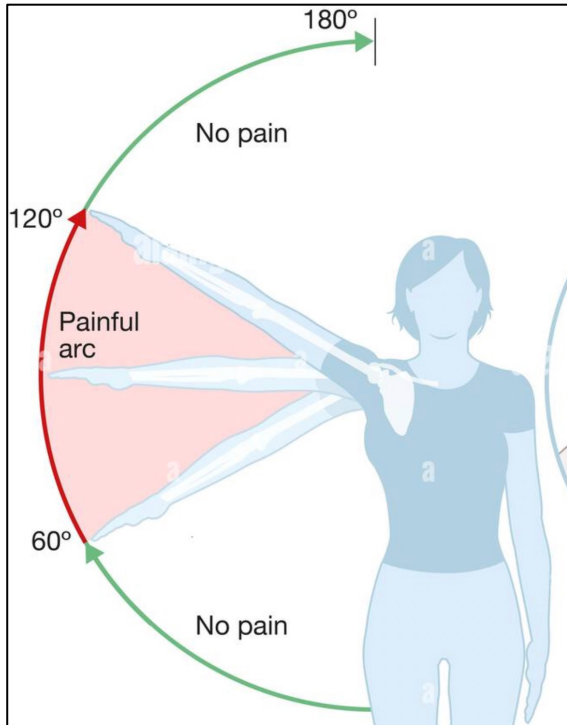
- Permet de mettre en évidence un déficit dans les muscles rotateurs externes (**sous-épineux** et **petit-rond**)



Épaule : Tests spécifiques

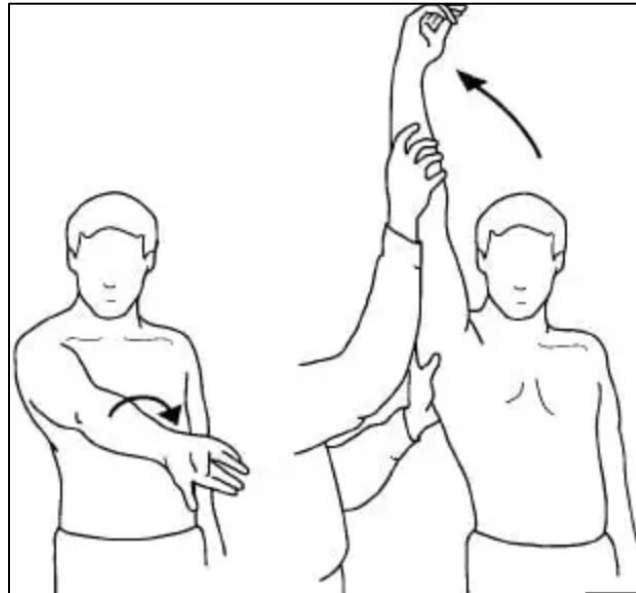
Coiffe des rotateurs : Arc douloureux

- La présence d'un arc douloureux entre l'abduction de l'épaule entre 60-120° est très évocatrice d'un **conflit sous-acromial**



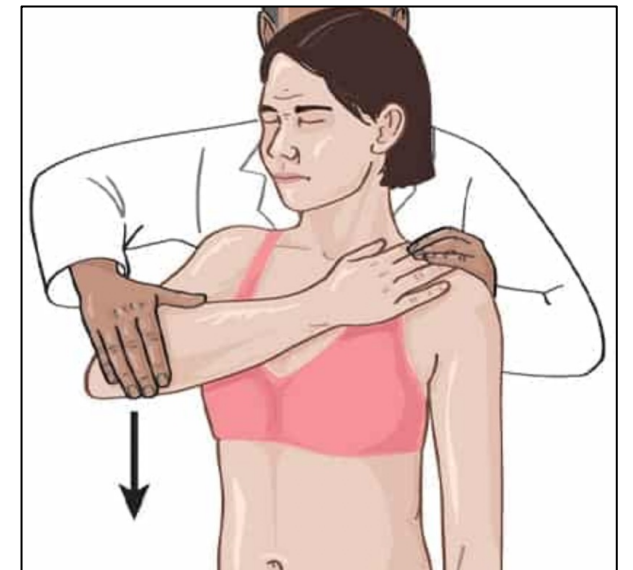
Coiffe des rotateurs : Test de Neer

- Mise en évidence d'un **conflit sous-acromial**
Attention à bien stabiliser soi-même la scapula, et effectuer passivement l'extension de l'épaule



Coiffe des rotateurs : Test de Yocum

- Mise en évidence d'un **conflit sous-acromial**
Complémentaire au test de Neer.



Épaule : Tests spécifiques

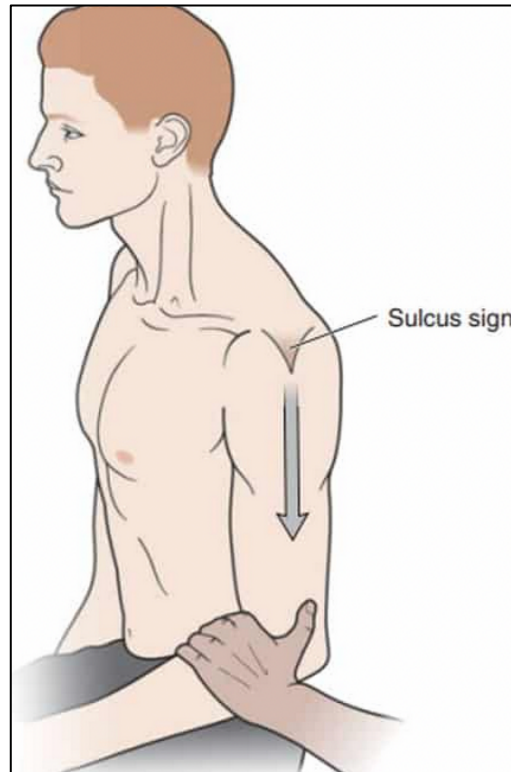
Instabilité: Test d'appréhension ant/post

- Permet de mettre en évidence une **instabilité** de l'articulation (= subjectif, décrite par le patient)



Instabilité: Test de laxité ant/post/inf

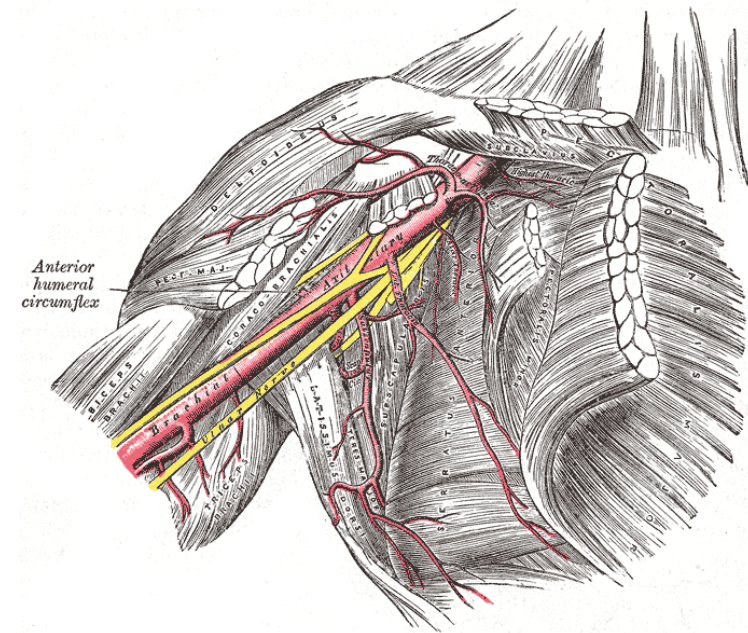
- Permet de mettre en évidence une **laxité** de l'articulation (= objectif, visible lors du test). Stabiliser l'épaule, puis tirer vers le bas, en avant et en arrière et observer la mise en évidence d'un sillon



Chef long du biceps : Palm-up test

- Permet de mettre en évidence une tendinopathie du tendon du **chef long du biceps**





Luxation de l'humérus :

- **Définition :** Le type de luxation le plus fréquent, en lien avec la faible congruence entre la tête humérale et la fosse glénoïde. La luxation peut avoir lieu antérieurement (le plus fréquent) ou postérieurement (rare), et fait le plus souvent suite à un traumatisme (sauf la luxation postérieure, qui se voit presque uniquement dans les crises d'épilepsies ou après une électrocution).
- **Cliniques :** Douleurs, diminution de l'amplitude articulaire, palpation d'un « creux » dans l'interligne articulaire.
- **Diagnostic :** La radiographie de face et de profil sont indispensables pour exclure une fracture et confirmer le diagnostic. On peut fréquemment voir des lésions de Hill-Sachs (partie postérieure de la tête humérale) et de Bankart (partie antérieure de la fosse glénoïde). Dans les cas de luxation postérieure, on parle Hill-Sachs inversé.
- **Traitement :** Des **manœuvres** peuvent repositionner la tête humérale dans l'espace approprié. Si nécessaire, par exemple en cas de luxation à répétitions, on peut effectuer une correction chirurgicale.

Fracture humérus :

- **Définition :** Résulte le plus souvent d'un trauma direct ou indirect. Elles sont classées en fracture proximale (population âgée), diaphysaire ou distale (pédiatrique).
- **Cliniques :** Signe classique de fracture (douleurs, déformation, crépitement osseux, palpation de la fracture...). Attention à toujours exclure une lésion nerveuse (surtout N. radial) et vasculaire.
- **Diagnostic :** Nécessite une radiographie avec incidence de face et de profil.
- **Traitement :**
 - Conservateur : Pour les fractures non-déplacées et non-ouverte
 - Chirurgical : Pour les fractures déplacées ou ouverte

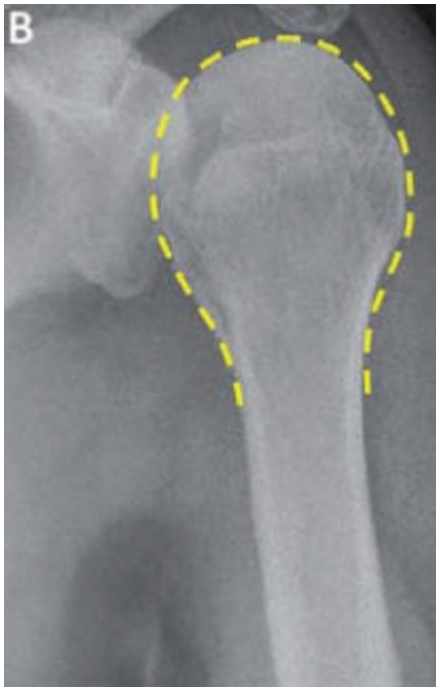
Lésion des tissus mous de l'épaule:

- **Syndrome de conflit sous-acromial :**
 - Symptômes causés par la compression des tendons de la coiffe des rotateurs (supra-épineux > le plus souvent), généralement consécutive à un rétrécissement de l'espace sous-acromial (surutilisation, inflammation ou dégénérescence, ou combinaisons des trois). À terme, risque de tendinite et de rupture des tendons.
 - Le diagnostic est uniquement clinique, mais la radio ou l'IRM peuvent mettre en évidence un rétrécissement de l'espace sous-acromial, un œdème des tendons de la coiffe des rotateurs...
 - Cliniquement: **Arc douloureux** entre 60-120° lors de l'abduction active, **test de Neer** pathologique. Effectuer les tests spécifiques relatifs à la fonction des différents muscles de la coiffe des rotateurs.
- **Capsulite rétractile :**
 - Inflammation et fibrose de la capsule articulaire. Maladie bénigne et fréquente de la femme après 40 ans.
 - **Cliniques :** Douleurs, rigidité, diminution progressive de l'amplitude articulaire dans tous les plans.
 - **Diagnostic :** Le diagnostic est généralement clinique. L'IRM permet de mettre en évidence un épaississement de la capsule articulaire et des ligaments.
 - Évolution **spontanément favorable** après quelques mois, maximum 1 année en général

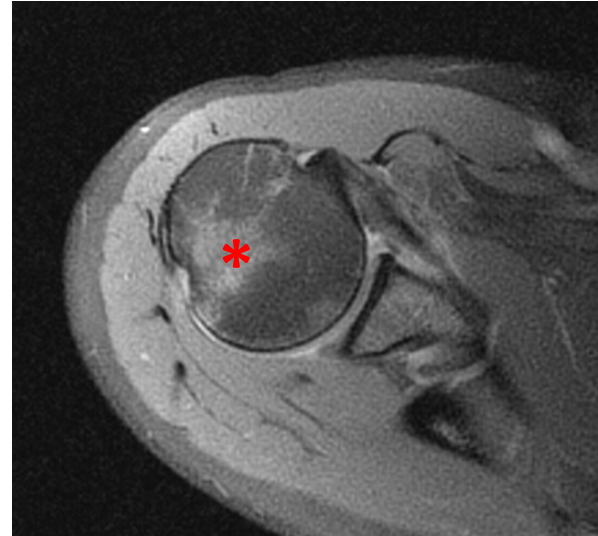
Luxation antéro-inférieure



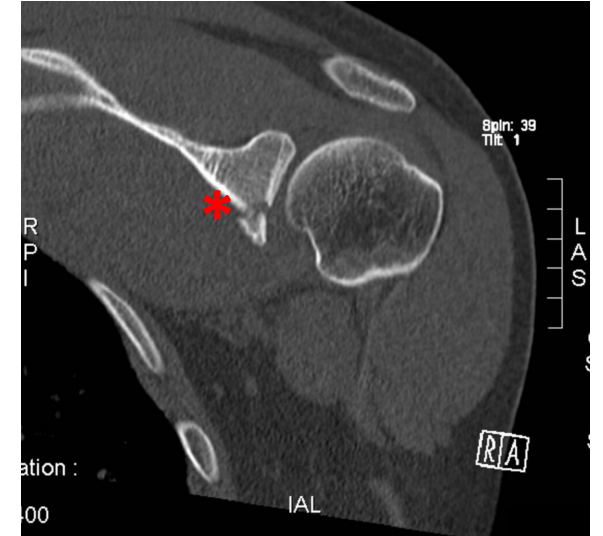
Luxation postérieure



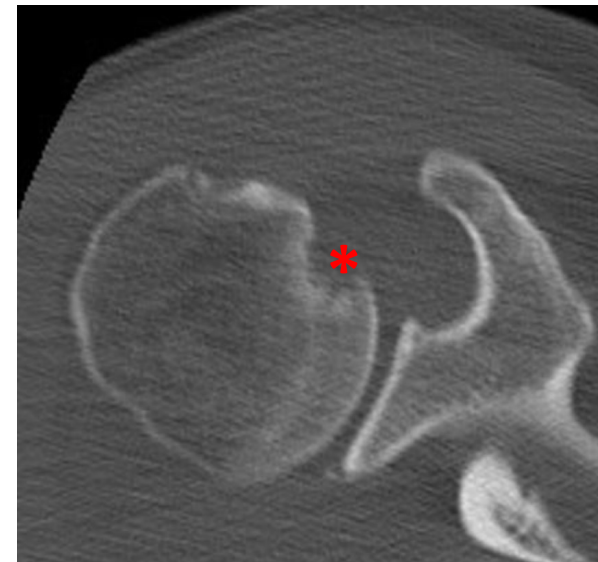
**Luxation antérieur avec lésion de Hill-Sachs
à la face postérieure de la tête humérale**

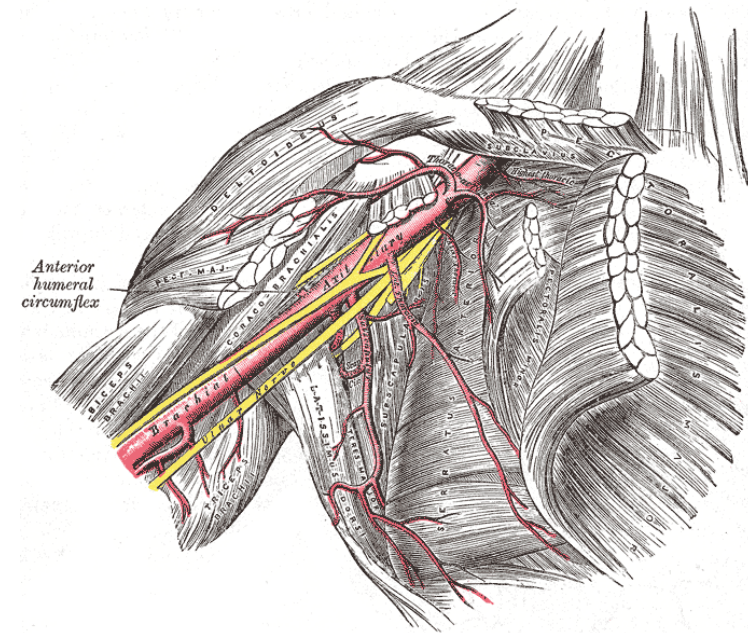


**Luxation antérieur avec lésion de Bankart
à la face antérieure de fosse glénoïde**



**Luxation postérieur avec lésion de Hill-Sachs
« inversé », à la face ant. de la tête humérale**





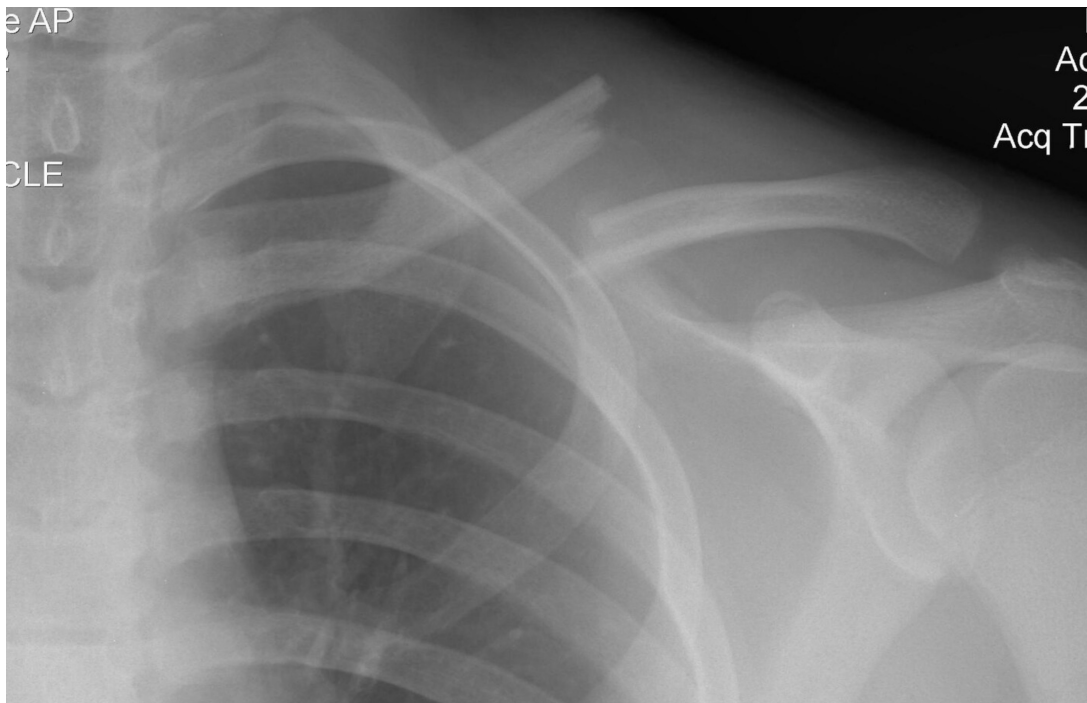
Fracture de la clavicule :

- **Définition :** Fracture fréquente à la naissance puis chez les enfants et les adolescents. Survient le plus souvent après une chute sur l'épaule.
Classifié en fonction de la localisation, la majorité surviennent au tiers intermédiaire.
- **Cliniques:** Relativement aspécifique : rougeur, chaleur, douleur, diminution de l'amplitude de mouvement de l'épaule. Douleurs importante à la palpation
- **Diagnostic:** La radiographie permet de confirmer le diagnostique.
Si nécessaire exclure une lésion vasculaire par artériographie.
- **Traitement :** Le plus souvent uniquement conservateur (4-6 semaines), à l'exception des fractures déplacées.

Luxation du coude:

- **Définition :** Le coude est la seconde articulation la plus souvent luxée après l'épaule, le plus souvent survenant après une chute avec la paume en surextension.
Luxation simple : luxation sans fracture associée
Luxation complexe : luxation avec fracture associée
- **Cliniques:** Déformité, instabilité, douleurs et incapacité à mobiliser l'articulation.
- **Diagnostic:** La radiographie est diagnostique. On voit parfois le « fat pad sign », lorsque du liquide s'accumule en avant et en arrière de l'articulation
- **Traitement :** Les luxations simples sont prises en charges conservativement avec de l'immobilisation.
Reprise chirurgicale en cas de luxation complexe

Fracture clavicule



Luxation simple



Fat pad sign



Luxation complexe

